Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 7ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810373

Processo nº 0003161-92.2023.8.17.4001

AUTOR(A): NINA ROSA SOARES TAVORA

RÉU: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

SENTENÇA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. LEI Nº 9.656/1998. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE GONARTROSE DE JOELHO DIREITO. REQUISIÇÃO MÉDICA PARA PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO COM SYNOLIS 80MG/4ML. SUBSTÂNCIA COM REGISTRO NA ANVISA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 465/2021. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE QUE É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA.

– Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Súmula 608 do STJ.

- Em que pese antiga divergência interna no Superior Tribunal de Justiça, sempre perfilhei o entendimento que define o "*caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde*" (AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

- A exemplificatividade do RPES da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ademais, acha-se recentemente consolidada no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

- A operadora plano de saúde pode estabelecer quais as doenças serão cobertas, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser alcançado pelo paciente, tampouco afastar o material e a técnica especificamente requisitados pelo médico assistente.

- O procedimento de infiltração da substância derivada do ácido hialurônico (Synolis) se revelou como artefato indispensável para o sucesso do procedimento e a consequente melhoria da higidez física da paciente portadora de gonartrose (CID M17).

- A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde rende ensejo à indenização por dano moral. Súmula 35 do TJPE. Quantia fixada em acordo com os princípios da

proporcionalidade e razoabilidade.
- Pedidos que se julgam procedentes.

Vistos, etc.

NINA ROSA SOARES TAVORA promove esta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO em face de **UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**, ambas devidamente qualificadas e representadas.

Consta da inicial que, ostentando a condição de segurada da promovida e estando em dia com as prestações decorrentes do vigorante contrato de assistência médico-hospitalar, a parte demandante viu-se acometida de gonartrose do joelho direito (CID M17), com risco irreversível às articulações acaso não tratada corretamente. Relata que, de acordo com requisitório médico, necessita de tratamento de punção articular através do procedimento de infiltração com Synolis 80mg/4ml, onde é introduzida medicação dentro do espaço intra-articular através de injeção.

Acresce dizendo que formulou requerimento administrativo, porém o mesmo foi negado sob justificativa de que inexistiria comprovação de eficácia do medicamento.

Em vista deste estado de coisas, invocando a legislação pertinente, veio a Juízo pleitear a condenação da operadora ré na obrigação de custear todas as despesas com o tratamento solicitado pelo médico assistente, inclusive em sede de tutela da urgência, bem como em indenização por danos morais que estima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juntou documentação e comprovou o preparo.

Decisão proferida em sede de Plantão Judiciário (ID nº 136699901) deferindo a tutela provisória liminarmente.

Regularmente citada, a operadora UNIMED SÃO PAULO apresentou contestação sob ID nº 140244296 suscitando que o contrato se encontra submetido às determinações da Lei nº 9.656/1998 e narrando ter autorizado o procedimento de infiltração, porém a substância solicitada (Synolis) não se encontra prevista no Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, rol esse que entende taxativo.

Descreve ainda que diversos estudos atestariam a ausência de eficácia do Synolis para a hipótese concreta, e que apesar de contar com registro na ANVISA sob número 80419110009 como produto para a saúde (solução para preenchimento intra-articular), não se trata de medicamento, de modo que não seria compelida a cobrir seu custeio. Ao enfim, insurge-se contra a configuração de quaisquer danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos atriais.

A parte demandante apresentou réplica (ID nº 144001751) rebatendo os argumentos contestatórios e reprisando os pedidos exordiais.

Os contendores não manifestaram interesse na dilação probatória ou na autocomposição, conforme petições de ID nº 149018987 (demandante) e nº 148987051 (promovida).

Houve alegações finais reiterativas.

Vieram-me então os autos conclusos para imediato sentenciamento, nos exatos moldes do art. 355, I, CPC/2015.

Relatados, PRONUNCIO-ME.

Estando agora o feito em ordem e inexistindo questões prévias pendentes de apreciação, adentro de logo ao *meritum causae.*

Cogita-se de ação visando cobertura de tratamento de gonartrose de joelho mediante infiltração da substância Synolis, em que se discute se a referida substância é ou não de cobertura obrigatória.

Pois bem.

De proêmio, é cristalino que o caso *sub judice* versa sobre uma relação de consumo, de trato sucessivo, devendo ser observado o Código de Defesa do Consumidor. Não é outro o teor da **Súmula 608 do STJ**.

Ainda neste viés, é de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem no esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.

Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.

Em nosso País, o direito à existência digna é refletido, entre outros aspectos, pela obrigação atribuída a quem quer que seja (Estado, operadoras de planos de saúde suplementar etc.) de realizar ações integradas destinadas a assegurar a prestação dos direitos inerentes à saúde, à previdência e à assistência social, incluídas, nesse contexto, ações que garantam acesso universal igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim é que qualquer omissão no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.

A Constituição Federal assim prescreve:

> **Art. 196**. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Sobre a matéria, constitui fundamento basilar da legislação consumerista a defesa do direito maior à vida e à saúde, consoante art. 6º, I, CDC.

O código protetivo dispõe que as cláusulas restritivas de direitos devem estar redigidas de maneira destacada, possibilitando assim a fácil percepção da parte contratante que, por se tratar de simples aderente e ostentar posição econômica induvidosamente inferior, qualifica-se como hipossuficiente.

Em razão do quadro clínico do segurado (ID nº 136673086), considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento de infiltração com Synolis, derivado do ácido hialurônico, seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida (art. 5º, caput, art. 196, CF/88).

A previsão legal contida no §4º do artigo 54 do CDC, ao tratar dos contratos de adesão, dispôs que "*as cláusulas que implicarem limitações de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão*".

Com efeito, nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

Há de se destacar que, em conformidade com o regramento estampado na legislação consumerista, o direito lastreado na boa fé ostenta especial relevância em prol do consumidor, mormente quando se cuida de situação de risco no que concerne à higidez física dos pacientes (arts. 5º e 196 da Constituição Federal) situação essa que se acha patenteada no teor do documento médico que sinaliza para a necessidade de submeter a suplicante à referida infiltração com o objetivo de facilitar o contato entre duas superfícies ósseas, como ocorre no interior da articulação do joelho direito da parte autora.

Com efeito, cabível assentar que a perpetuação da doença sem o devido tratamento ensejaria dano irreparável, o qual exige premente e pronta alberga judicial.

Para além disso, cumpre assentar que o CDC é norma de ordem pública (art. 5º, XXXII, da CF), sendo certo que o plano de assistência médico-hospitalar é contrato de trato sucessivo, que se renova a cada mensalidade.

A Constituição Federal assim prescreve:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

É que entende este Juízo, em consonância com a moderna jurisprudência, que a circunspeção e seriedade da moléstia, passível de cobertura contratual como no caso, bem como o prazo para o respectivo tratamento, não podem ser aferidos pela análise administrativa da empresa seguradora. Antes, é ilação a que apenas o médico assistente pode chegar, mediante a anamnese da situação em concreto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que compete ao médico assistente determinar qual o tratamento que deverá ser aplicado ao paciente.

Neste viés, o Superior Tribunal de Justiça já apascentou que "***o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura***" (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

Outrossim, é lamentável a conduta da seguradora, em sede de defesa, no sentido de afirmar que autoriza a infiltração mas que não haveria cobertura para a substância Synolis requisitada pelo médico assistente.

No caso vertente, verificando os fatos e argumentos expendidos na exordial e os documentos acostados, não sobeja dúvida que o pacto firmado entre os litigantes reveste-se da roupagem estritamente adesiva. Por outro lado, é cristalino que o caso *sub judice* versa sobre uma relação de consumo, devendo portanto ser observado o Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a Lei Consumerista, as cláusulas restritivas de direitos devem estar redigidas de maneira destacada, possibilitando assim a fácil percepção da parte contratante que, por se tratar de simples aderente e ostentar posição econômica induvidosamente inferior, qualifica-se como hipossuficiente.

Todavia, ainda que haja cláusula contratual ou dispositivo regulamentar administrativo nesse sentido, tal realidade não seria suficiente para a empresa demandada eximir-se de custear a prótese, haja vista que tal procedimento configurou-se como indispensável à higidez física da paciente.

Em razão do quadro clínico da segurada, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento e do material específico requerido seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização da cirurgia indicada, em situação de urgência ou emergência.

Assim, a operadora é obrigada a garantir o procedimento da infiltração incluindo a substância Synolis solicitada pelo médico assistente, substancia essa, ademais, que já conta com registro na ANVISA sob número 80419110009.

Desse modo, julgo ser ilegal a recusa à concessão da cobertura, vez que apesar da ANS, no seu Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não ter incluído o Synolis nas diretrizes de utilização para o procedimento, cuido tratar-se de **listagem meramente exemplificativa e de cobertura mínima**, não devendo ser considerada taxativa a excluir a responsabilidade de fornecimento do tratamento, sendo a negativa incompatível com os princípios da equidade e boa-fé.

O tema se encontrava divergente entre a Quarta e a Terceira Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Desde então, sempre perfilhei o entendimento da Terceira Turma, a qual, no contexto, transcrevo:

> AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015). DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO PALBOCICLIBE (IBRANCE). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE NÃO ENQUATRAMENTO NA DIRETRIZ DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E DIRETRIZES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA TERCEIRA TURMA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do medicamento antineoplásico PALBOCICLIBE (IBRANCE) a paciente acometida de câncer de mama metastático, tendo havido recusa da operadora sob o fundamento de ausência de enquadramento do caso nas diretrizes de utilização previstas no rol de procedimentos mínimos da ANS.
2. Caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, na linha da jurisprudência pacífica desta TURMA, firmada com base na função social do contrato de plano de saúde.
3. Caso concreto em que a paciente se encontra acometida de doença oncológica grave e progressiva, de modo que a recusa genérica de cobertura (sem instauração de junta médica nos termos da RN ANS 424/2017) deixou a paciente padecendo à própria sorte no tratamento da doença, desatendendo assim à função social do contrato, segundo a linha de entendimento desta TURMA.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1911407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL.
REEXAME DE PROVAS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ.
3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ainda neste viés, a Corte de Uniformização Infraconstitucional também se define "*no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente".* (AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Ademais, também recentemente, caiu por terra a discussão existente sobre a taxatividade do Rol da ANS e a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não previstos na lista ofertada pela Agência Reguladora.

A já mencionada Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656, de 1998 (http://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:1998-06-03;9656), estabelece que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (RPES), atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Desta feita, acha-se definitivamente profligado o entendimento pelo "rol taxativo" para a cobertura de planos de saúde. Assim, as operadoras de assistência à saúde poderão ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos ainda que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Tratamentos fora dessa lista deverão ser aceitos, desde que cumpram uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Vejamos:

> Art. 10. (…)
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
> **I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;** ou
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

É bem esse o caso dos autos, mormente porque a substância já conta com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (nº 80419110009).

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

Passo a analisar a cláusula excludente.

Nos contratos onde existem cláusulas que venham prejudicar a parte mais fraca da relação de consumo, em detrimento das máximas da boa-fé objetiva e da confiança, há que se as considerar abusivas, devendo ser reconhecidas judicialmente por meio de ação ou reconvenção, de exceção ou por ato *ex officio* do Juiz.

O artigo 51, incisos IV e IX do CDC, dispõe:

> Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)
> IV estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa fé ou a eqüidade; (...)
> IX deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor.

Inobstante tal realidade, a empresa demandada persistiu em negar a cobertura do laser, ao argumento de que não estaria obrigada a fornecê-la, olvidando assim as garantias constitucionais e da legislação consumerista.

Sopesando, em conclusão todos os argumentos expendidos, tenho que se afeiçoa induvidoso que o pleito formulado pela autora merece acolhimento.

Por outro lado, a exclusão do dever de cobertura por cláusula contratual ou instrumentos de convênio firmados com terceiros, malgrado descrita em supostos estudos atuariais, constitui indisfarçável e frontal violação do regramento estampado na legislação protetiva do hipossuficiente porquanto soa implausível, eivada a não mais poder de abusividade e, *pour cète cause*, nula de pleno direito, o que fica aqui expressamente reconhecido e declarado, na forma do art. 52 inc. IV da Lei 8.078/1990, e art. 168 par. único do nCC (antigo, art. 146 par. único).

Não se pode olvidar que, imbuída da mais intangível boa-fé, acedeu a parte autora às letras previamente anotadas pela seguradora na esperança de ver resguardados seus direitos e liberdades constitucionais, no que dizem com sua dignidade, vida e incolumidade física e mental. Decerto, perseguir valores indevidos ou negar cobertura securitária quando se evidencia negligência ou mesmo cavilosidade na arguição do dispositivo da avença concernente à imprevisão no ajuste é clausular a iniquidade e a abusividade, o que, face à ordem normativa consumerista, não pode prosperar.

Por isso, entendo que a mencionada negativa, ainda que lastreada em anteparo contratual ou no parecer de médicos de comitê subordinado à operadora, não merece guarida no ordenamento jurídico pátrio.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização do seu tratamento nos exatos moldes indicados pelo médico assistente.

É de se ressaltar que o dever de assistência à saúde dos cidadãos surge como uma das formas de garantia do direito à vida localizado no caput do art. 5º da CF, caracterizando-se, pois, como cláusula pétrea, de modo a impedir que o legislador, assim como o administrador, criem situações que impliquem esvaziamento do conteúdo desse dispositivo constitucional.

Para além da estreita relação com o direito à vida, o direito à assistência à saúde possui intrínseca relação com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, razão pela qual, conclui-se, qualquer previsão legal, bem como quaisquer atitudes tomadas pelo Poder Público que provoquem o esvaziamento do direito à vida trará, como corolário, o desrespeito à dignidade da pessoa humana, pois são dois vetores considerados igualmente fundamentais pela Constituição.

Em nosso País, o direito à existência digna é refletido, entre outros aspectos, pela obrigação atribuída a quem quer que seja (Estado, operadoras de planos de saúde suplementar etc.) de realizar ações integradas destinadas a assegurar a prestação dos direitos inerentes à saúde, à previdência e à assistência social, incluídas, nesse contexto, ações que garantam acesso universal igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assim é que qualquer omissão no papel de garantidor desse direito abrirá ensejo para a propositura de medidas judiciais, não somente naquelas situações em que ele não garantir o direito à saúde, mas também quando o assegurar de forma ineficiente.

No caso vertente, verificando os fatos e argumentos expendidos na exordial e os documentos acostados, não sobeja dúvida que o pacto firmado entre os litigantes reveste-se da roupagem estritamente adesiva. Por outro lado, é cristalino que o caso *sub judice* versa sobre uma relação de consumo, devendo, portanto, ser observado o Código de Defesa do Consumidor.

Em razão do quadro clínico da segurada, considerar legal e admissível a intenção da parte ré de escusar-se do custeio do tratamento requerido seria negar amparo e garantia ao bem jurídico maior tutelado pelo nosso ordenamento jurídico, qual seja, a vida saudável.

O princípio constitucional do direito à vida e à saúde e do dever das seguradoras, em substituição ao Estado, oferecer sua escorreita prestação não devem ser considerados em planos inferiores aos dos casuísmos normativos ou contratuais, nem à burocracia das firmas contraentes, revelando-se direito líquido e certo da parte acionante, amparável na via ordinária, a reparação pelas expensas com a realização da cirurgia indicada.

De rigor, portanto, a pretendida cobertura em favor da parte demandante.

Apoiando este pensar, confira-se:

> Apelação cível. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. **Recusa de custeio de tratamento com o medicamento Synolis. Diagnóstico de osteocondropatia/tendinopatia do quadríceps e patelar. Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade. Elemento essencial do tratamento de moléstia coberta no contrato. Expressa indicação médica quanto à necessidade do medicamento.** Nulidade da cláusula de exclusão. Aplicação da Súmula nº 102 do TJSP. Obrigação da requerida de fornecer cobertura ao tratamento, conforme prescrição médica. Precedentes. Apelo desprovido.
> (TJSP; Apelação Cível 1027128-33.2021.8.26.0554; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2023; Data de Registro: 14/08/2023)
>
> PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação da ré. **Prescrição ao autor de tratamento com infiltrações do medicamento Synolis VA 40ml. Negativa de custeio. Alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS e de uso off label. Medicamento registrado na ANVISA. Recusa indevida. Abusividade nos termos dos arts. 14 e 51, IV e § 1º do CDC**. Incidência da Súmula nº 102 do TJSP. Danos morais não configurados. Descumprimento contratual que, por si só, não implica em violação dos atributos da personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença reformada em parte, afastada a indenização por danos morais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
> (TJSP; Apelação Cível 1117273-76.2020.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021)

Por fim, não se pode negar que, em princípio, devem ser atendidas as Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ocorre que, ante o caráter exemplificativo dessa lista de procedimentos, também suas diretrizes devem ser encaradas *cum granum salis*, posto que, como é cediço, a norma jurídica anda a pé, enquanto o fato social corre a cavalo.

Amparando essa ilação, confira-se:

> EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME ONCOLÓGICO. PET SCAN. CONSUMIDORA DIAGNOSTICADA COM TUMOR NEUROENDÓCRINO. ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
> 1. Tratando-se de consumidora diagnosticada com tumor neuroendócrino com indícios de metástase, a indicação de exame PET-SCAN deve ser autorizada pela operadora de plano de saúde, por adequação às Diretrizes de Utilização – DUT do Rol de Procedimentos da ANS.
> **2. Ainda assim, independentemente de adequação às DUT, o caráter exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS torna obrigatória a cobertura do exame requisitado, uma vez que se trata de procedimento previsto como obrigatório.**
> 3. Recurso desprovido.

(TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0001590-47.2020.8.17.9480, Rel. RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior, julgado em 23/02/2022, DJe)

Quanto ao pedido indenizatório, exsurge nitidamente que ele merece prosperar nos termos os artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil.

O dano e a relação de causalidade estão presentes não só pela negativa de vigência do contrato, mas pelo sentido de perda em relação à reparação da saúde em momento delicado da parte autora, objetivo primordial do procedimento médico irregularmente vetado.

Nesse diapasão, vejo que a prática intentada pela ré infringe o princípio constitucional da solidariedade e contraria os arts 4º e 6º, I, CDC, no que atine à proteção à vida e à saúde, bem assim o art. 14, §1º, pelo defeito na prestação do serviço por não o fornecer da maneira esperada pelo consumidor de boa-fé.

Respeitante ao pedido alusivo aos danos morais, permite-se este Juízo deixar assentada breve conceituação pela qual "danos morais são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa de direito em seu *patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico*" (SILVA, Wilson de Melo da. **O Dano Moral e sua Reparação**, Rio, 1995, n° 01).

Encampando esta linha de pensamento, confira-se a **Súmula 35 do TJPE**: "*A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral*".

Por certo, infligir ao paciente - profundamente debilitado pela grave moléstia que lhe acometeu e pelo decurso da idade - o ônus de vir a Juízo buscar a efetivação das suas prerrogativas, em detrimento da paulatina dor e sofrimento que se acha experimentando, significa vulnerar-lhe com absurda iniquidade a aprazia e o bem-estar, carecendo da pronta compensação financeira.

Por suposto, "*embora geralmente o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada*" (STJ - AgRg no REsp 1.328.978/RS - Terceira Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - Julg. 13.11.2012 - DJe 20.11.2012)

O lesionamento, na espécie, não depende de prova de outros prejuízos ao patrimônio material ou físico do postulante, porquanto se caracteriza *in re ipsa*.

Em conclusão, tenho ser indevida a recusa da parte ré em cobrir todas as despesas com o tratamento médico-hospitalar do paciente nos termos solicitado pelo médico assistente, devendo suportar os custos com a cobertura devida em relação ao contrato celebrado entre as partes, por abusiva eventual cláusula de restrição, além da indenização por dano moral, este arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando a mediana extensão do dano suportado pela autora e as condições pessoais das partes.

Firmado nessas razões, e por tudo mais que restou provado nos autos, tenho por imperativo julgar **PROCEDENTES** os pedidos que se acham contemplados na presente ação ordinária para:

a) **a)** reconhecendo a abusividade da recusa de cobertura, **confirmar** a liminar e **condenar** a seguradora demandada na **obrigação de fazer** consistente na cobertura do procedimento de infiltração da substância Synolis 80mg/4ml, incluindo todos os materiais, medicamento, artefatos, utensílio e equipamentos imprescindíveis ao sucesso do tratamento, nos exatos moldes da requisição do médico assistente, o que já restou implementado.

b) **b) impor** obrigação de indenizar a parte postulante, em aspecto compensatório pelos sofrimentos e **danos morais** que valoro no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a repercussão e reprovabilidade do fato, bem assim a condição socioeconômica das partes litigantes (art. 944, nCC), quantia a ser monetariamente corrigida pela tabela ENCOGE desde este decisum (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação (art. 405, nCC).

Na oportunidade, extingo o presente feito por sentença com apreciação nuclear, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, imputando à parte ré o ônus sucumbencial representado pelas custas processuais e taxa judiciária adiantadas, além de honorários advocatícios na ordem de 15% do valor da condenação (obrigação de fazer + indenização), tudo lastreado nos arts. 82, §2º, e 85, §2º, ambos do CPC/2015, e Súmula 199 do TJPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recife-PE, data digitalmente certificada.

Robinson José de Albuquerque Lima

Juiz de Direito Titular

bfsma

Assinado eletronicamente por: ROBINSON JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA
19/02/2024 13:20:19
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 161096933

24021913201972800000157354606

IMPRIMIR GERAR PDF